

CONSTIPACIÓN

Alimentos ricos en fibras que deben administrarse

- Todas las ensaladas crudas
- Garbanzos, lentejas, habas, porotos, milanesas de soja
- Arroz integral
- Avena, salvado (también utilizar para la preparación de milanesas)
- Espinaca, acelga
- Choclo
- Puerro
- Zanahoria, zapallo
- Tomate
- Cebolla
- Galletas de salvado o integral
- Pan integral
- Ciruela, moras, frambuesas, frutillas, peras, durazno, damasco, kiwi, uva, sandia
- Cítricos (naranja, mandarina, pomelo, limón, si es en jugo: con pulpa)
- Frutas secas (pasas)
- Almendras, nueces
- Barras de cereal

Reentrenamiento de hábitos evacuatorios

El tratamiento de la constipación requiere de paciencia y la conformación de un equipo con el niño y la familia. En la etapa del control de esfínteres debe evitarse que los glúteos queden atrapados en la pélela o que el niño tenga sensación de caerse dentro del inodoro. Debe tener punto de apoyo para los pies para favorecer la prensa abdominal (nunca dejar que cuelguen).

No hay que avergonzarlo, atemorizarlo ni castigarlo, ni extremar los hábitos obsesivos de higiene.

Con los niños mayores hay que consensuar el reentrenamiento del hábito de defecar dedicando tiempo de concurrir al baño después de las comidas 2 veces por día (10 a 15 minutos), y evitar las conductas retentivas en respuesta a la urgencia de defecar.

Laxante:

Seguimiento: Tener paciencia, la etapa de reeducación y mantenimiento dura meses.

Una vez que el niño logra el objetivo de una evacuación diaria de consistencia normal se puede disminuir la dosis de laxantes en forma gradual, incrementando paulatinamente la fibra de la dieta.

Al término de 6 a 12 meses se puede discontinuar el tratamiento con laxantes con la precaución de mantener al paciente en control y reiniciando el tratamiento farmacológico si la constipación recurre.